MATERI PEMBELAJARAN • KEPERAWATAN

HIPERKES

untuk Meningkatkan Keselamatan Pasien

Higiene Perusahaan • Kesehatan Kerja • Keselamatan Kerja



Disusun oleh

dr Juwita Ninda Suherman, M.Kes

Bahan ajar 30 slide | Format presentasi 16:9

ORIENTASI PEMBELAJARAN

Apa yang akan dipelajari?

01 • Memahami

Menjelaskan sejarah singkat, konsep, ruang lingkup, dan tujuan HIPERKES.

02 • Mengenali

Mengidentifikasi bahaya biologis, kimia, fisik, ergonomi, dan psikososial di fasilitas kesehatan.

03 • Mengendalikan

Memilih pengendalian risiko sesuai hierarki dan menerapkan praktik kerja aman.

04 • Menerapkan

Menganalisis kasus dan menjelaskan dampak HIPERKES terhadap mutu serta keselamatan pasien.

FOKUS UTAMA: PERAWAT • PASIEN • LINGKUNGAN PELAYANAN

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN

Dari respons kecelakaan menuju pencegahan

Sejarah dalam sumber ajar menunjukkan perubahan cara pandang: dari menerima kecelakaan sebagai nasib menuju pengelolaan risiko.

1911

Awal konsep K3

Buku K3 yang diunggah menyebut Amerika Serikat sebagai titik awal perubahan.

Fase awal

Kuratif

Kecelakaan ditangani setelah terjadi; tanggung jawab sering dibebankan pada pekerja.

Perkembangan

Preventif

Fokus bergeser pada pengenalan bahaya, pencegahan, dan kontrol.

Saat ini

Sistemik

K3 menjadi tanggung jawab organisasi dan seluruh pekerja.

Relevansi di rumah sakit: bukan menunggu perawat tertusuk jarum atau pasien cedera—risiko harus dikenali sebelum insiden.

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN

Mengapa HIPERKES relevan di rumah sakit?

Tempat kerja berisiko

Perawat berhadapan dengan pasien, alat medis, bahan kimia, limbah, beban fisik, dan tuntutan emosional.

Kontak intensif

Waktu kontak perawat dengan pasien relatif panjang; praktik kerja perawat berpengaruh pada mutu pelayanan.

Risiko saling terkait

Bahaya yang mencederai tenaga kesehatan juga dapat mengganggu proses pelayanan dan meningkatkan risiko bagi pasien.

Perubahan cara pandang

REAKTIF

Menangani setelah kecelakaan / infeksi terjadi

PROAKTIF

Mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, lalu mengevaluasi risiko

KONSEP DASAR HIPERKES

Apa itu HIPERKES?

pen

an ke

Higiene perusahaan

Mengenali, menilai, dan mengendalikan faktor lingkungan kerja yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan.

Kesehatan kerja

Memelihara derajat kesehatan fisik, mental, dan sosial pekerja melalui promosi, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan.

Keselamatan kerja

Mencegah cedera dan kecelakaan yang berkaitan dengan alat, bahan, proses, lingkungan, serta cara kerja.

HIPERKES bukan sekadar memakai APD. HIPERKES adalah sistem untuk membuat pekerjaan dan lingkungan pelayanan lebih aman.

Empat bidang yang saling terhubung

Penerapan HIPERKES memerlukan pendekatan multidisiplin.



Contoh integrasi: pemindahan pasien yang aman membutuhkan alat bantu, teknik ergonomi, komunikasi tim, dan pemantauan kondisi pasien.

Tujuan HIPERKES di fasilitas kesehatan

Tujuan perlindungan pekerja berjalan searah dengan pelayanan pasien yang aman.

Lindungi tenaga kesehatan

Mencegah cedera, pajanan, dan penyakit akibat kerja.

Ciptakan lingkungan aman

Mengendalikan bahaya pada ruang perawatan, laboratorium, dan area penunjang.

Jaga kesinambungan layanan

Mengurangi gangguan kerja akibat kecelakaan, sakit, atau paparan.

Lindungi pasien & pengunjung

Mencegah kontaminasi, kesalahan proses, dan insiden lingkungan.

Dua keselamatan, satu sistem

Perlindungan pekerja adalah salah satu prasyarat lingkungan pelayanan yang aman.

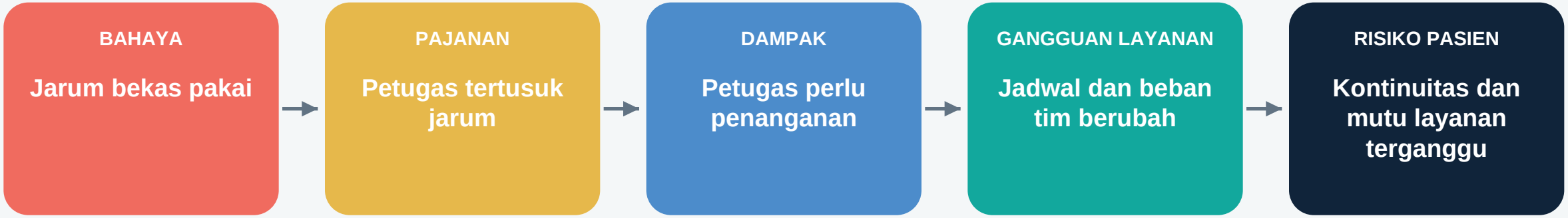
KESELAMATAN TENAGA KESEHATAN + **LINGKUNGAN KERJA AMAN** = **PELAYANAN LEBIH AMAN**

Perawat yang terlindungi dapat bekerja lebih konsisten dan fokus.

- Pengendalian infeksi melindungi petugas sekaligus pasien.
- Lingkungan tertata mengurangi risiko jatuh, tertukar, dan gangguan pelayanan.
-

Rantai dampak: dari bahaya ke keselamatan pasien

Contoh alur sebab-akibat yang perlu diputus melalui program HIPERKES.



Titik intervensi: rekayasa alat keselamatan, prosedur kerja, pelatihan, pelaporan pajanan, dan evaluasi.

IDENTIFIKASI BAHAYA

Peta bahaya di rumah sakit

Gunakan kategori bahaya untuk menata inspeksi dan penilaian risiko.

B

BIOLOGIS

Darah, cairan tubuh, TB, bioaerosol

K

KIMIA

Disinfektan, obat sitotoksik, gas medis

F

FISIK

Lantai licin, listrik, radiasi, kebisingan

E

ERGONOMI

Mengangkat pasien, postur janggal, repetisi

P

PSIKOSOSIAL

Shift, kelelahan, stres, kekerasan

Satu aktivitas dapat memiliki lebih dari satu jenis bahaya.

Bahaya biologis: pajanan yang tidak selalu terlihat

n, bio

Sumber pajanan

Darah dan cairan tubuh • jarum/benda tajam • percikan • aerosol di area berisiko.

Dampak potensial

Infeksi pada petugas; kontaminasi silang dapat membahayakan pasien dan lingkungan.

Situasi berisiko

Tindakan invasif • pengambilan spesimen • perawatan luka • pembersihan alat dan limbah.

Prinsip utama

Terapkan kewaspadaan standar pada setiap pasien sesuai risiko tindakan.

- Lakukan kebersihan tangan dan gunakan APD sesuai pajanan.
- Kelola benda tajam dan limbah infeksius pada wadah yang sesuai.
-

Benda tajam: cegah sebelum terjadi pajanan

Tertusuk jarum merupakan contoh pajanan patogen melalui darah.



Ilustrasi wadah benda tajam

Pencegahan di titik tindakan

Siapkan wadah sharps sebelum prosedur; jangan menutup kembali jarum dengan dua tangan; buang segera setelah digunakan.

Jika terjadi tertusuk / pajanan

Hentikan tindakan dengan aman, lakukan pertolongan awal sesuai protokol fasilitas, segera laporkan dan ikuti penilaian medis pascapajanan.

Bahaya kimia: aman dalam penggunaan dan penyimpanan

Bahan B3 di rumah sakit dapat berupa disinfektan, antiseptik, reagensia, obat sitotoksik, serta gas medis/nonmedis.

INHALASI

Uap / aerosol

KULIT

Percikan / kontak

TERTELAN

Tangan / makanan tercemar

Sebelum menggunakan

Baca label dan Safety Data Sheet (SDS/LDK); pastikan wadah, ventilasi, dan prosedur sesuai.

Setelah menggunakan

Tutup dan simpan bahan dengan benar; lakukan dekontaminasi dan pembuangan sesuai prosedur.

Bahaya fisik di area pelayanan

Kondisi fisik yang buruk dapat mencederai petugas maupun pasien.

Lantai basah

Risiko terpeleset dan pasien jatuh.

Listrik & alat

Kabel rusak, alat tidak laik, sengatan listrik.

Radiasi

Paparan di area radiologi; perlu proteksi dan pembatasan akses.

Pencahayaan & bising

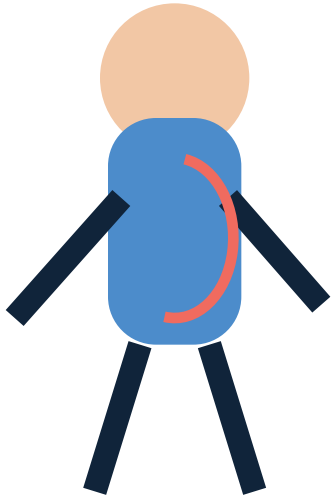
Mengganggu konsentrasi, komunikasi, dan kenyamanan.

PATIENT SAFETY LINK: AREA AMAN • ALAT LAIK • KOMUNIKASI JELAS

BAHAYA ERGONOMI

Ergonomi: lindungi punggung, lindungi pasien

Pemindahan pasien, posisi kerja janggal, dan gerakan berulang dapat menimbulkan gangguan muskuloskeletal.



Postur dan beban

Risiko utama

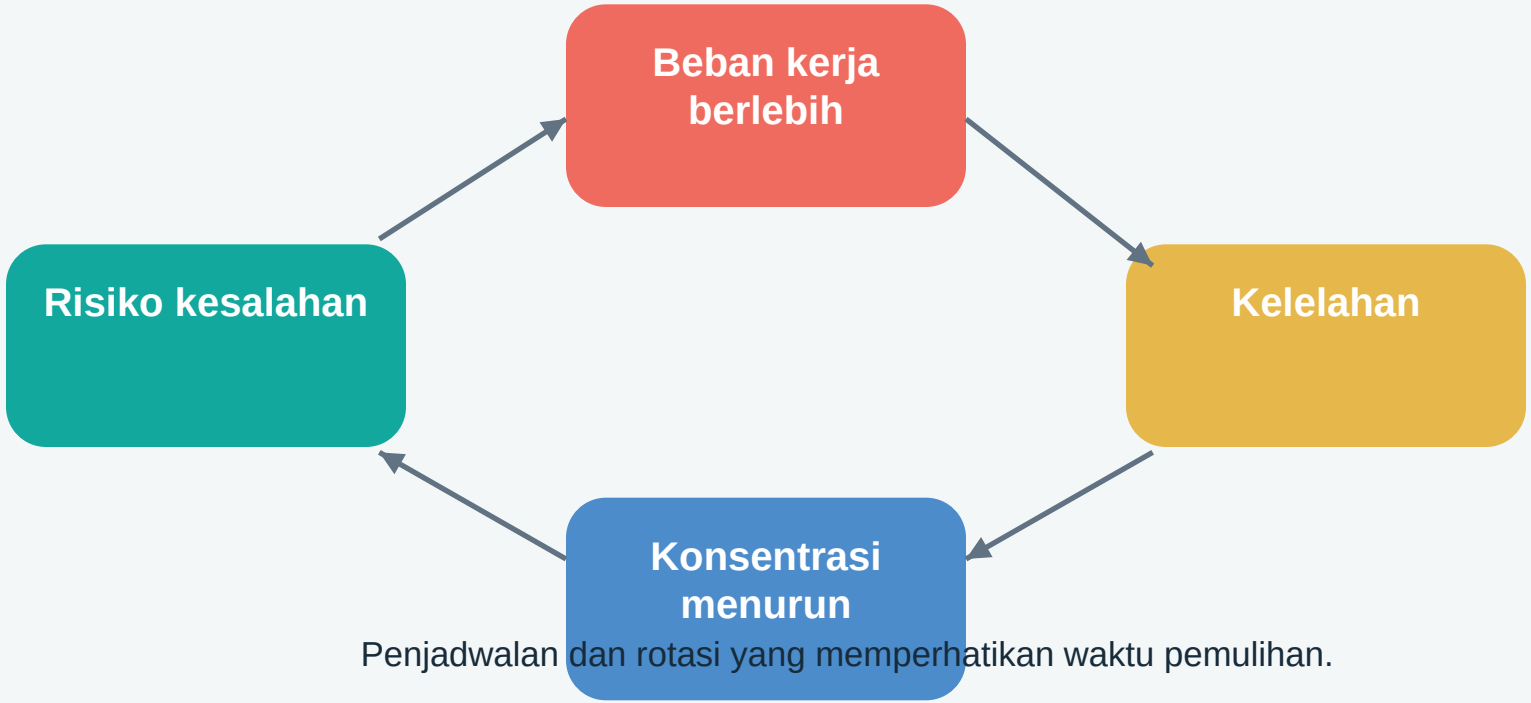
Mengangkat pasien tanpa bantuan • memutar pinggang • bekerja membungkuk • mendorong tempat tidur tanpa teknik tepat.

Praktik lebih aman

Nilai kemampuan pasien; gunakan alat bantu/transfer aid; minta bantuan tim; atur tinggi tempat tidur; dekatkan beban ke tubuh.

Kelelahan dan stres juga merupakan bahaya kerja

Shift, beban kerja, tuntutan emosional, dan waktu pemulihan yang tidak cukup dapat memengaruhi performa.



Pencegahan organisasi

- Penjadwalan dan rotasi yang memperhatikan waktu pemulihan.
- Kecukupan staf, jeda istirahat, dukungan tim, dan akses konseling.
- Laporkan kelelahan yang berisiko terhadap tindakan klinis.

Penyakit akibat kerja (PAK)

kerjaa

Infeksi terkait kerja

Risiko infeksi akibat pajanan biologis di tempat pelayanan.

Gangguan muskuloskeletal

Nyeri punggung, bahu, atau ekstremitas akibat beban dan postur kerja.

Gangguan kulit / pernapasan

Iritasi atau dermatitis akibat bahan kimia; gangguan akibat pajanan tertentu.

Kunci: kenali hubungan antara pajanan, jenis pekerjaan, waktu paparan, dan keluhan kesehatan.

KESEHATAN KERJA

Empat bentuk pelayanan kesehatan kerja

Pelayanan yang terpadu mencakup promosi hingga rehabilitasi

1

PROMOTIF

Edukasi K3, gizi, kebugaran, dan budaya sehat.

2

PREVENTIF

Pemeriksaan kesehatan, imunisasi, kontrol pajanan.

3

KURATIF

Penanganan gangguan kesehatan, pengobatan, dan rujukan.

4

REHABILITATIF

Pemulihan kemampuan dan penyesuaian kerja.

Penerapan di rumah sakit: program kesehatan pekerja, imunisasi sesuai risiko, pemeriksaan berkala, penanganan pajanan, dan dukungan kembali bekerja.

Siklus higiene: kenali – nilai – kendalikan

Higiene perusahaan menilai faktor lingkungan kerja secara kualitatif dan kuantitatif.

01

IDENTIFIKASI

Walk-through, observasi, checklist bahaya.

02

EVALUASI

Nilai tingkat pajanan, frekuensi, dan dampak.

03

PENGENDALIAN

Pilih kontrol pada sumber, jalur, dan pekerja.

04

PEMANTAUAN

Inspeksi ulang dan perbaikan berkelanjutan.

Hasil evaluasi menjadi dasar tindakan korektif, bukan sekadar dokumen.

MANAJEMEN RISIKO

Menilai risiko sebelum menentukan prioritas

Risiko di[illegible] gkat keparahan dampak.

KEMUNGKINAN ↑ / KEPARAHAN →			
4	8	12	16
3	6	9	12
2	4	6	8
1	2	3	4

Contoh: lantai basah di koridor

Kemungkinan terpeleset tinggi saat ramai; dampaknya dapat berupa cedera petugas atau pasien. Prioritaskan pengeringan, pembatas area, dan perbaikan sumber bocor.

Contoh: beban memindahkan pasien

Risiko meningkat jika pasien berat/tidak kooperatif dan tidak tersedia alat bantu. Gunakan penilaian kebutuhan bantuan dan alat transfer.

PENGENDALIAN RISIKO

Hierarki pengendalian: jangan mulai dari APD

Pilih pengendalian yang paling efektif dan kombinasikan bila diperlukan.

1 **ELIMINASI** — Hilangkan sumber bahaya

2 **SUBSTITUSI** — Ganti dengan alternatif lebih aman

3 **REKAYASA** — Isolasi, desain alat, ventilasi, pengaman

4 **ADMINISTRATIF** — SOP, pelatihan, jadwal, rambu, supervisi

5 **APD** — Perlindungan personal sebagai lapisan terakhir

PENERAPAN KLINIS

Kewaspadaan standar: praktik inti di setiap pelayanan

Tindakan pencegahan disesuaikan dengan risiko dan prosedur fasilitas.

Kebersihan tangan

Sebelum dan sesudah kontak sesuai indikasi.

APD sesuai risiko

Sarung tangan, masker, pelindung mata, gaun bila diperlukan.

Etika batuk & respirasi

Kendalikan sumber droplet dan gunakan ventilasi sesuai kebutuhan.

Keamanan injeksi

Gunakan alat steril sekali pakai dan teknik aman.

Alat & lingkungan

Bersihkan dan disinfeksi sesuai prosedur.

Limbah & linen

Pisahkan, kemas, dan alirkan sesuai kategori.

PENERAPAN KLINIS

Pengelolaan bahan dan limbah secara aman

B3 dan limbah yang tidak dikelola dapat membahayakan pekerja, pasien, pengunjung, dan lingkungan.

KENALI
Label & SDS

→

PISAHKAN
Kategori limbah

→

SIMPAN
Wadah sesuai

→

ANGKUT
Petugas & rute

→

BUANG
Prosedur resmi

Jangan lakukan

Mencampur limbah, meninggalkan benda tajam di baki, atau memindahkan bahan tanpa identitas.

Lakukan

Gunakan wadah berlabel, tutup rapat, ikuti alur internal, dan laporkan tumpahan atau kerusakan.

PENERAPAN KLINIS

Pemindahan pasien: aman, terencana, kolaboratif

Ergonomi bukan sekadar posisi punggung; keselamatan pasien juga harus dipertahankan.

01 • NILAI

Kesadaran, kekuatan, kemampuan mengikuti instruksi.

02 • SIAPKAN

Atur rem, tinggi tempat tidur, ruang gerak, dan alat bantu.

03 • KOMUNIKASI

Jelaskan langkah; hitung bersama; tetapkan peran tim.

04 • PINDAHKAN

Gunakan teknik dan alat bantu; hindari gerakan memutar mendadak.

Bila beban atau kondisi pasien melebihi kemampuan satu petugas, jangan memaksakan pemindahan sendiri.

PELAPORAN DAN PEMBELAJARAN

Insiden, kecelakaan, dan near miss harus dipelajari

Pelaporan membantu organisasi menemukan celah sistem dan mencegah kejadian berulang.

NEAR MISS

Hampir terjadi cedera, tetapi belum menimbulkan dampak.

INSIDEN TANPA CEDERA

Kejadian telah berlangsung, belum menimbulkan cedera.

KECELAKAAN

Kejadian menimbulkan cedera atau gangguan kesehatan.

Amankan pasien dan area terlebih dahulu.

- Laporkan sesuai sistem dan tenggat fasilitas.
- Analisis faktor manusia, alat, lingkungan, komunikasi, dan sistem—hindari budaya menyalahkan.
- Tetapkan tindakan korektif dan cek efektivitasnya.
-

PERAN PERAWAT

Peran perawat dalam HIPERKES

Perawat adalah pelaksana praktik aman sekaligus pengamat risiko di titik pelayanan.

PENGKAJI

Mengenali bahaya dan kondisi kesehatan pekerja.

EDUKATOR

Mengingatkan tim tentang SOP, APD, dan pencegahan.

PELAKSANA

Menerapkan tindakan aman dan kewaspadaan standar.

PELAPOR

Melaporkan pajanan, insiden, dan kondisi tidak aman.

KOLABORATOR

Bekerja sama dengan PPI, K3RS, dokter, dan manajemen.

EVALUATOR

Menilai kepatuhan dan memberi masukan perbaikan.

HIPERKES perlu dukungan sistem, bukan usaha individu

Kebijakan, fasilitas, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi harus berjalan bersama.

MANAJEMEN	Kebijakan, sumber daya, target, evaluasi
UNIT K3RS / PPI	Panduan, pelatihan, surveilans, koordinasi
KEPALA RUANGAN	Supervisi, briefing, inspeksi, tindak lanjut
TENAGA KESEHATAN	Kepatuhan SOP, pelaporan, praktik aman

Siklus perbaikan: rencanakan → laksanakan → periksa → tindak lanjuti.

DISKUSI KASUS

Studi kasus: perawat tertusuk jarum setelah injeksi

Gunakan kasus ini untuk melatih pembahasan faktor penyebab, pengendalian, dan tindakan segera.

SITUASI

Perawat terburu-buru saat jam sibuk. Jarum bekas diletakkan di baki karena wadah sharps tidak tersedia di dekat tempat tindakan.

Pertanyaan analisis

Apa bahayanya? Apa faktor individu dan sistem? Pengendalian apa yang paling efektif? Apa tindakan segera setelah pajanan?

Arah jawaban

Sediakan wadah pada titik tindakan; desain alur kerja; larang penundaan pembuangan; edukasi dan audit; lakukan pelaporan dan evaluasi pascapajanan.

DISKUSIKAN DALAM KELOMPOK KECIL

PENUTUP

Lima pesan yang perlu dibawa ke praktik klinik

HIPERKES adalah bagian dari kompetensi profesional perawat.

1. **Kenali bahaya sebelum memulai tindakan.**
2. **Kendalikan risiko dari sumbernya; APD bukan satu-satunya solusi.**
3. **Keselamatan pekerja dan keselamatan pasien saling terhubung.**
4. **Laporkan pajanan, near miss, dan kondisi tidak aman.**
5. **Bangun budaya keselamatan melalui kerja tim dan perbaikan sistem.**

SAFE WORKPLACE → SAFE CARE → SAFE PATIENT

REFERENSI

Daftar pustaka dan sumber pembelajaran

Materi ini disusun berdasarkan sumber utama di atas yang diunggah, dan dapat diperbarui sesuai kebutuhan pembelajaran.

- Sujoso, A. D. P. (2012). *Dasar-Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jember University Press. Bab I, IV, VIII–IX.
- Hendrik, Anshar, & Arpandjam'an. (2020). *Modul Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Poltekkes Kemenkes Makassar. Bab 1 dan Bab 5.
- Aprilliani, C., dkk. (2022). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*. PT Global Eksekutif Teknologi. Bab I, V–VIII, XI–XII.
- *Makalah HIPERKES* (file unggahan). Bagian HIPERKES, kesehatan kerja, peran dan tugas perawat HIPERKES.
- *HIPERKES (Higiene Perusahaan dan Keselamatan Kerja) untuk Paramedis* (file presentasi unggahan).
- Poltekkes Kemenkes Denpasar. (2025). *Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*. SK Direktur HK.02.03/F.XXXII/4192/2025.

Catatan akademik: data historis dan uraian teori mengikuti sumber unggahan. Untuk penerapan klinis, selalu ikuti SOP, kebijakan K3RS/PPI, dan regulasi yang berlaku di fasilitas masing-masing.